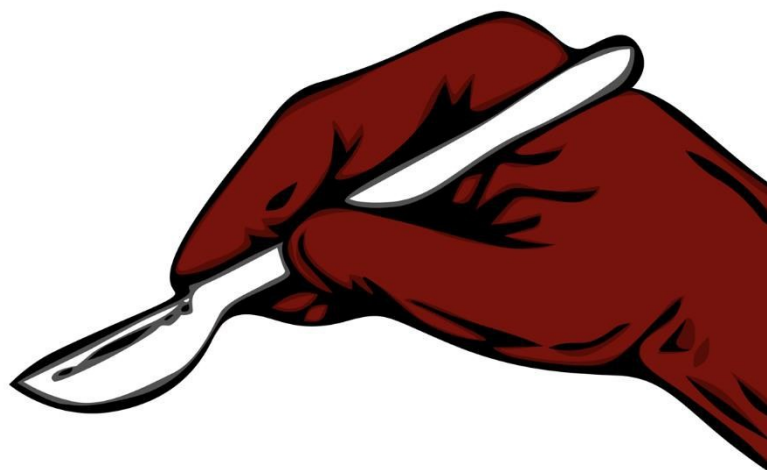




ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.П. КОШЕЛЯ

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ

6–8 НОЯБРЯ 2026

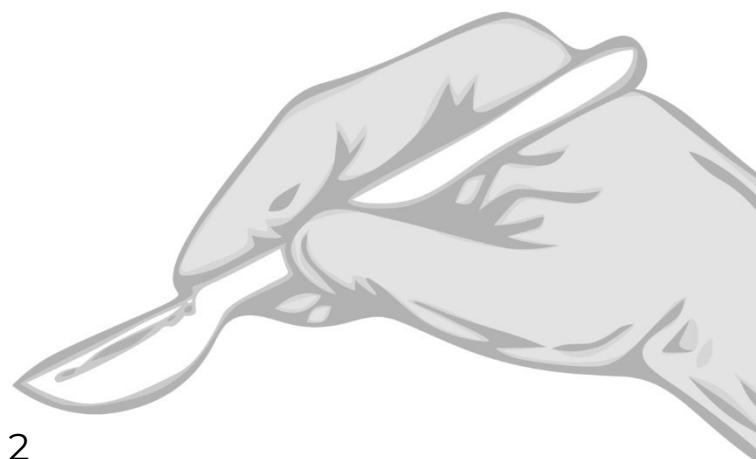


ТОМСК, 2026



СОДЕРЖАНИЕ

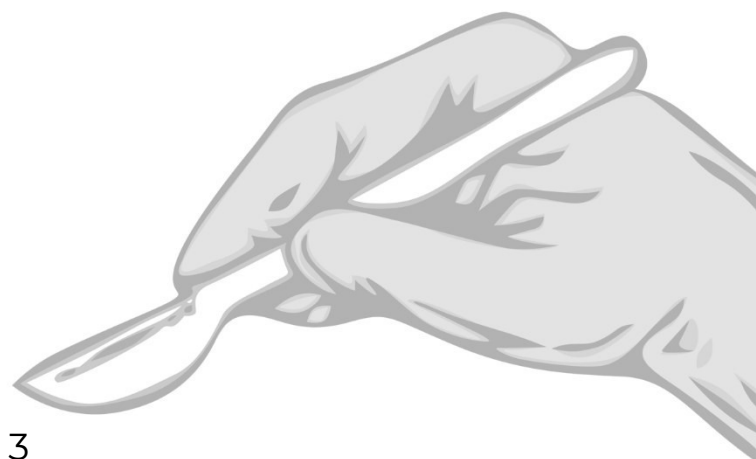
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.....	3
ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ.....	4
РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ.....	5
ОПИСАНИЕ КОНКУРСОВ ПЕРВОГО ТУРА.....	8
«Абдоминальная хирургия».....	8
«Сосудистый шов».....	15
«Торакальная хирургия».....	22
«Наложение сухожильного шва».....	28
«Реконструктивно-пластическая хирургия. Первый этап».....	31
«Вязание хирургических узлов».....	35
ОПИСАНИЕ КОНКУРСОВ ВТОРОГО ТУРА.....	37
«Травматология».....	37
«Оперативная урология».....	41
«Реконструктивно-пластическая хирургия. Второй этап».....	47
«Оперативная гинекология».....	51
ОПИСАНИЕ КОНКУРСА ТРЕТЬЕГО ТУРА.....	58
«Сегментарная резекция толстой кишки с формированием анастомоза конец в конец на экспериментальном животном»	58





ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

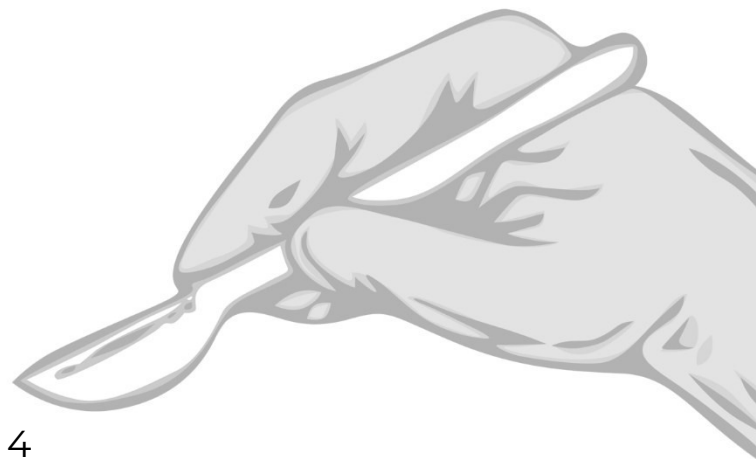
- **Окороков Александр Олегович** — проректор по учебной работе Сибирского государственного медицинского университета, к.м.н. врач-акушер-гинеколог;
- **Баширов Сергей Рафаэлевич** — заведующий кафедрой общей хирургии Сибирского государственного медицинского университета, д.м.н., врач-хирург высшей категории, член ассоциации колопроктологов России;
- **Ивченко Андрей Олегович** — заведующий кафедрой факультетской хирургии Сибирского государственного медицинского университета, д.м.н., врач-ангиохirurg отделения сосудистой хирургии областной клинической больницы г. Томска;
- **Ибрагимов Фазли Аладинович** — старший лаборант учебного центра экспериментальной хирургии, врач-ординатор по специальности травматология и ортопедия;
- **Сулеймен Жусип** — руководитель студенческого объединения «Хирургия без границ»;
- **Стариченко София Сергеевна** — заместитель руководителя студенческого объединения «Хирургия без границ»;
- **Апаршев Никита Александрович** — руководитель пресс-службы студенческого объединения «Хирургия без границ».





ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ

- **Баширов Сергей Рафаэлевич** — заведующий кафедрой общей хирургии Сибирского государственного медицинского университета, д.м.н., врач-хирург высшей категории, член ассоциации колопроктологов России;
- **Ивченко Андрей Олегович** — заведующий кафедрой факультетской хирургии Сибирского государственного медицинского университета, д.м.н., врач-ангиохirurg отделения сосудистой хирургии областной клинической больницы г. Томска;
- **Бощенко Вячеслав Семенович** — заведующий кафедрой общей и детской урологии-андрологии Сибирского государственного медицинского университета, д.м.н., врач-уролог высшей категории;
- **Соловьев Михаил Михайлович** — профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии Сибирского государственного медицинского университета, д.м.н., врач-хирург высшей категории;
- **Егунова Мария Алексеевна** — ассистент мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра, доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н.;
- **Яценко Анатолий Евгеньевич** — ассистент кафедры хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии, врач-ортопед-травматолог;
- **Ибрагимов Фазли Аладинович** — старший лаборант учебного центра экспериментальной хирургии, врач-ординатор по специальности травматология и ортопедия;
- **Мытник Андрей Павлович** — врач-ординатор пластической хирургии.





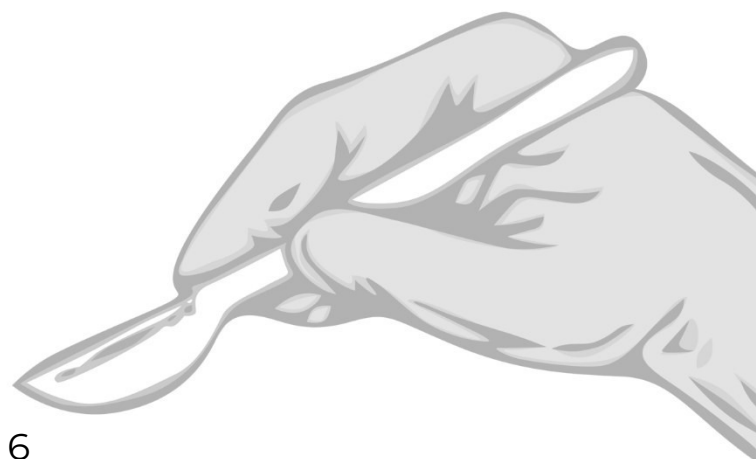
РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ

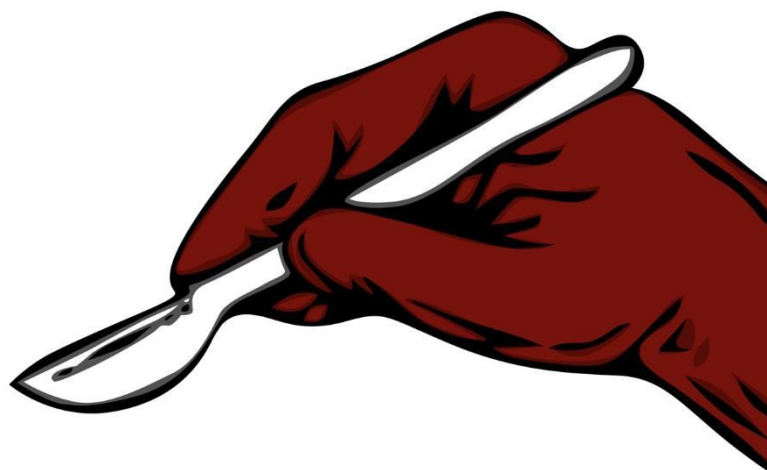
- **Место проведения Олимпиады:** Новоанатомический корпус СибГМУ;
- **Дата начала регистрации команд Олимпиады:** 8 октября 2026 года;
- **Даты проведения Олимпиады:**
 - I тур – 6 ноября 2026 года (начало в 9:00);
 - II тур – 7 ноября 2026 года (начало в 9:00);
 - III тур – 8 ноября 2026 года (начало в 9:00).
- В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 1 – 6 курсов по направлениям подготовки «лечебное дело» и «педиатрия», 4, 5 курсов по направлению подготовки «стоматология» СибГМУ.
- Участником Олимпиады является команда, подавшая заявку на участие по специальной форме.
- Для участия в Олимпиаде участникам необходимо самостоятельно сформировать команду (хирургическую бригаду), состоящую из 3 участников (оператор, ассистент, медицинская сестра). При невозможности формирования команды участник имеет право подать заявку на участие. В данном случае Организаторы Олимпиады формируют команды самостоятельно.
- Во время участия в конкурсах роли хирургической бригады распределяются командой самостоятельно.
- Информация о регистрации, отчетная информация, программа и регламент размещаются на официальном сайте СибГМУ и в специальной группе социальной сети «ВКонтакте»: vk.ru/surgery_olympiad_sibmed.
- Описание конкурсных заданий, методика выполнения заданий, критерии оценки указаны в программе Олимпиады.
- С целью идентификации участника каждой команды участник Олимпиады предоставляет студенческий билет или зачетную книжку.



РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ

- Для решения заданий нельзя пользоваться любыми справочными материалами, включая атласы, энциклопедии, словари, а также мобильные устройства.
- В случае несогласия с оценкой жюри команда Олимпиады имеет право подать заявление в Организационный комитет, в этом случае Организационным комитетом формируется апелляционная комиссия.
- Для выполнения конкурсных заданий хирургический инструментарий и расходный материал предоставляет Организатор Олимпиады. Команда имеет право использовать собственный хирургический инструментарий.
- Во время прохождения некоторых конкурсов Конкурсное жюри будет задавать случайные теоретические вопросы участвующей Команде. В случае неудовлетворительного ответа от команды, при оценке конкурса будет сниматься **1 балл** из общего количества полученных баллов за конкурс. Список возможных вопросов: используемый инструментарий в оперативном вмешательстве, используемый шовный материал, показания к оперативному лечению/неотложной помощи, осложнения при оперативном вмешательстве/неотложной помощи, знания топографической анатомии.
- При равенстве баллов между командами места будут распределены согласно приоритетности критериев. Главным критерием для любого конкурса является **время выполнения** задания, далее – решается индивидуально в зависимости от конкурса.

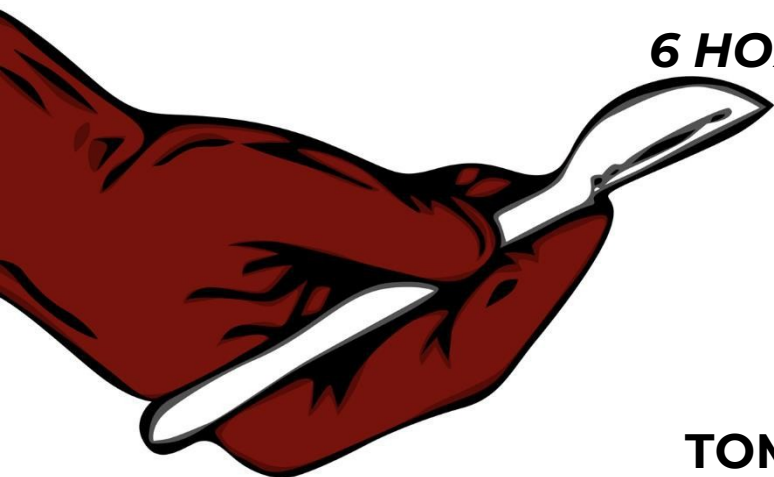




ПЕРВЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ

КОНКУРСЫ ТУРА: «Абдоминальная хирургия», «Сосудистый шов», «Торакальная хирургия», «Наложение сухожильного шва», «Реконструктивно-пластическая хирургия. Первый этап», «Вязание хирургических узлов».

6 НОЯБРЯ 2026



ТОМСК, 2026

ОПИСАНИЕ КОНКУРСОВ ПЕРВОГО ТУРА

«Абдоминальная хирургия»

Ситуационная задача:

Клиническая ситуация: в отделение общей хирургии ОГБУЗ ГKB № 1 бригадой скорой медицинской помощи доставлен больной К., 30 лет, с жалобами на выраженную слабость, головокружение, тошноту, многократную рвоту темными массами типа «кофейной гущи» и черный дегтеобразный стул в течение двух дней. Два дня назад пациент внезапно потерял сознание.

Анамнез: язвенная болезнь желудка в течение 7 лет, 6 лет назад оперирован по поводу перфоративной язвы желудка – выполнено ушивание язвы.

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, тоны сердца ясные. Пульс 110 уд/мин, АД 100/60 мм рт. ст. Живот правильной формы, от мечевидного отростка до пупка имеется послеоперационный рубец линейной формы. При пальпации живот мягкий, определяется умеренная болезненность в эпигастральной области. Симптомов раздражения брюшины нет. При ректальном исследовании определяется дегтеобразный стул.

Лабораторные исследования:

- ОАК: эритроциты $2,5 \cdot 10^{12}/л$, Hb 85 г/л, лейкоциты $13,0 \cdot 10^9/л$;
- ОАМ: без патологических изменений.

Инструментальные исследования:

- Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС): выявлена язва препилорического отдела желудка (диаметр 1,5 см) с активным кровотечением (Forrest IA). Проведена диатермокоагуляция кровоточащего сосуда с временным гемостазом.

Через 6 часов пациент отметил повторную рвоту «кофейной гущей», усилилась слабость, АД снизилось до 90/55 мм рт. ст. Повторная ФГДС подтвердила рецидив кровотечения (Forrest IA).

Диагноз: Язва препилорического отдела желудка, осложнённая активным кровотечением (Forrest IA).

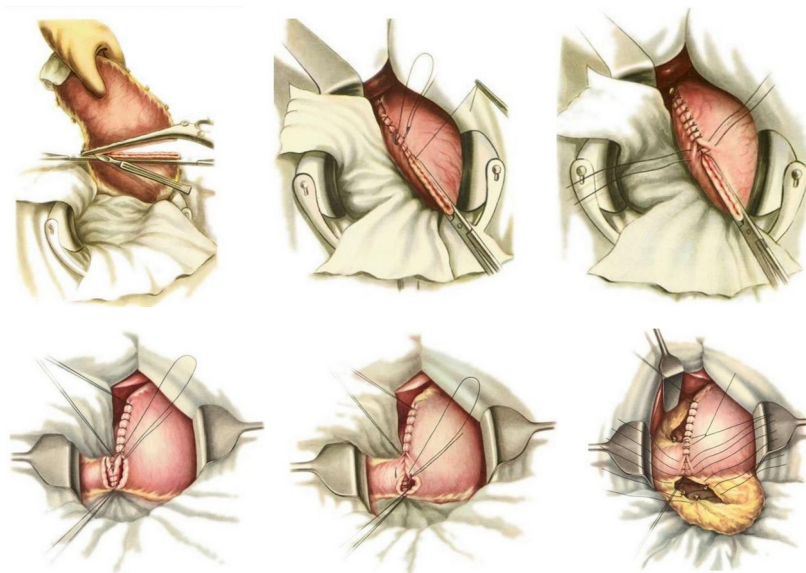


Начата интенсивная терапия: внутривенно ингибиторы протонной помпы, гемостатические препараты (транексамовая кислота), переливание 1000 мл эритроцитарной массы и 2000 мл кристаллоидов для коррекции кровопотери. На фоне рецидива кровотечения анализы показали: эритроциты $2,1 \cdot 10^{12}/л$, Hb 75 г/л, тромбоциты $190 \times 10^9/л$, протромбиновый индекс 95%. Учитывая неэффективность эндоскопического гемостаза и рецидив язвенного кровотечения, принято решение об экстренном оперативном вмешательстве. Под эндотрахеальным наркозом выполнена верхнесрединная лапаротомия.

Конкурсное задание:

Команде предлагается воспроизвести операцию **«Резекция желудка в модификации Бильрот I»**, выполнив следующие этапы за 60 минут:

- Дистальная резекция 2/3 желудка с учетом анатомических ориентиров;
- Мобилизовать желудок и двенадцатиперстную кишку;
- Формирование культи желудка с ушиванием культи желудка со стороны малой кривизны ручным двухрядным швом;
- Сохранить отверстие по линии резекции у большой кривизны, соответствующее просвету двенадцатиперстной кишки;
- Наложение двухрядного гастродуоденоанастомоза «конец в конец» с отверстием по линии резекции желудка у большой кривизны.



Описание препарата:

Органокомплекс (свиной) – желудок с участком тонкой кишки (длина – 20 см). Желудок со стороны кардии фиксирован к пенополистироловой поверхности. Препарат будет погружен в бокс глубиной 10–15 см.

Рекомендуемые инструменты:

- Иглодержатель (1 шт.);
- Пинцет анатомический (мин. 2 шт.);
- Ножницы Купера / Метценбаума (мин. 1 шт.);
- Кишечный жом эластичный (мин. 4 шт.);
- Ручка для скальпеля (1 шт.);
- Лезвие 23/24;
- Зажим по типу «москит» или Бильрот (мин. 2 шт.).

Рекомендуемый шовный материал:

- Полифиламентный рассасывающийся шовный материал на атравматической колющей игле (ПГА, викрил), USP 4/0 или USP 3/0, 2/0.

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра.

Время выполнения:

- Для получения максимального количества баллов по критерию «Время» конкурсное задание необходимо закончить за 60 минут;
- Для каждой команды проводится собственный отсчет времени;
- Отсчет времени начнется после выполнения всех подготовительных этапов;
- Стоп-время – 80 минут. После 80 минут оперативное вмешательство прекращается.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Правильная работа с инструментами	1 балл	Критерий соблюден;
		0 баллов	Неиспользуемые инструменты в «операционном поле», нарушение техники работы с инструментами и шовным материалом;
2	Правильная работа с тканями	1 балл	Деликатное обращение с тканями, отсутствие травматизации;
		0 баллов	Грубое обращение с тканями, их травматизация;
3	Слаженность работы в команде	3 балла	Критерий соблюден;
		1 балл	Взаимодействие между членами бригады в целом сохранено, но имеются отдельные недостатки, не оказывающие существенного влияния на качество работы;
		0 баллов	Нескоординированное взаимодействие между членами бригады; грубые нарушения, влияющие на качество работы;
4	Время выполнения задания	3 балла	<60 минут;
		2 балла	60–70 минут;
		1 балл	70–80 минут;
		0 баллов	>80 минут;
5	Резекция 2/3 желудка	3 балла	Резекция 2/3 желудка;
		1 балл	Резекция менее или более 2/3 желудка;
		0 баллов	Резекции не было;

6	Мобилизация желудка	2 балла	Мобилизация достаточна (1,0–1,5 см от зоны анастомоза), в зоне анастомоза отсутствует брыжейка, васкуляризация достаточна;
		1 балл	Наличие брыжейки в каком-либо участке шва, в остальных участках мобилизация адекватна;
		0 баллов	Обширная (более 2 см) деваскуляризация зоны анастомоза или присутствие брыжейки в проекции кишечного шва;
7	Мобилизация ДПК	2 балла	Мобилизация достаточна (1,0–1,5 см от зоны анастомоза), в зоне анастомоза отсутствует брыжейка, васкуляризация достаточна;
		1 балл	Наличие брыжейки в каком-либо участке шва, в остальных участках мобилизация адекватна;
		0 баллов	Обширная (более 2 см) деваскуляризация зоны анастомоза или присутствие брыжейки в проекции шва;
8	Локализация анастомоза у большой кривизны	1 балл	Да
		0 баллов	Нет
Оценка шва малой кривизны желудка			
9	Герметичность шва кривизны	4 балла	Герметичен;
		2 балла	Намокание линии шва;

	(проверяется путем антеградного заполнения желудка водой шприцем под давлением с наложением эластичных жомов)	0 баллов	Негерметичен (интенсивное просачивание или струйное подтекание на линии шва);
10	Эстетичность шва кривизны	4 балла	Одинаковые промежутки между стежками, одинаковое направление стежков, равномерное затягивание;
		2 балла	Либо различные промежутки между стежками, либо разное направление стежков, либо неравномерное затягивание стежков;
		0 баллов	Несоблюдение двух и более параметров;
11	Отсутствие шовного материала в просвете (для экстрамукозных швов)	3 балла	Отсутствие шовного материала в просвете;
		1 балл	Прорезывание шовного материала (менее 3 стежков в просвете);
		0 баллов	Прорезывание шовного материала (более 3 стежков в просвете);
Оценка гастродуоденоанастомоза			
12	Герметичность анастомоза (проверяется путем введения катетера в просвет кишки и нагнетания воды под давлением)	4 балла	Герметичен;
		2 балла	Намокание линии шва;
		0 баллов	Негерметичен (интенсивное просачивание или струйное подтекание на линии шва);
13	Проходимость анастомоза	4 балла	Отсутствие стеноза;
		2 балла	Стеноз (20–40% от диаметра первоначального просвета тонкой кишки);

		0 баллов	Стеноз (более 40% от диаметра первоначального просвета кишки);
14	Эстетичность анастомоза	4 балла	Одинаковые промежутки между стежками, одинаковое направление стежков, равномерное затягивание;
		2 балла	Либо различные промежутки между стежками, либо разное направление стежков, либо неравномерное затягивание стежков;
		0 баллов	Несоблюдение двух и более параметров;
15	Отсутствие шовного материала в просвете (для экстрамукозных швов)	3 балла	Отсутствие шовного материала в просвете;
		1 балл	Прорезывание шовного материала (менее 3 стежков в просвете);
		0 баллов	Прорезывание шовного материала (более 3 стежков в просвете);
Максимальное количество баллов			42

Ответственные за конкурс:

- Сулеймен Жусип, <https://vk.ru/zhusipsuleimen>;
- Барашкова Анастасия, <https://vk.ru/anastasiabarashkova>.

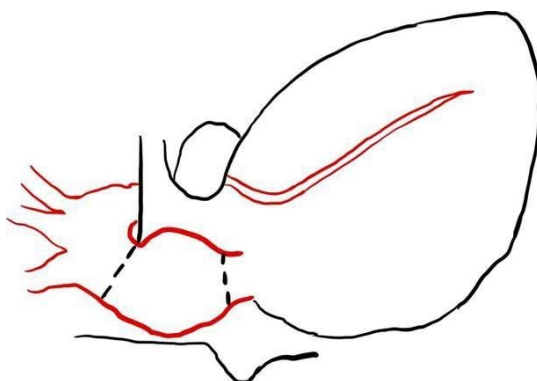


«Сосудистый шов»

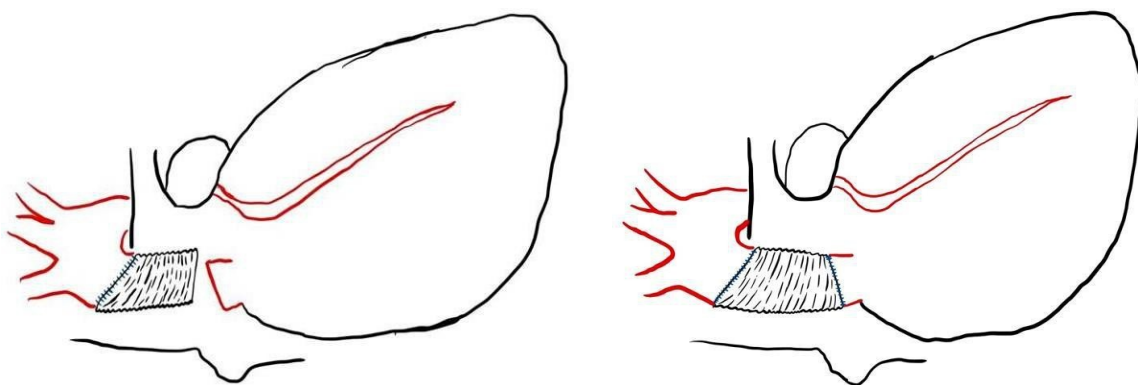
Ситуационная задача: пациент П. 58 лет поступил в НИИ кардиологии в плановом порядке с диагнозом: Аневризма восходящего отдела аорты. Диагноз установлен на основании спиральной компьютерной томографии с контрастированием. По результатам СКТ диаметр аорты на уровне синусов — 42 мм, максимальное расширение аорты до 58 мм на уровне бифуркации легочной артерии, проксимальнее уровня БЦС — 45 мм, нисходящая Ао — 31 мм, на уровне чревного ствола — 26 мм. По проведенным исследованиям: ЭхоКГ — ФВ 60%, КДО 116 мл, без значимой клапанной патологии, расширение восходящего отдела аорты; коронарография: тип кровообращения правый. Проксимальный стеноз ПМЖА 80% TIMI 2, стеноз 50% ОА TIMI 1. Остальные артерии без гемодинамически значимых стенозов. В качестве метода реваскуляризации миокарда выбрано АКШ.

Конкурсное задание: команде предлагается выполнить **надкоронарное протезирование восходящего отдела аорты** путем замещения резецированного сегмента восходящей аорты предоставленным **протезом кровеносного сосуда INTERGARD 18 мм**. После чего наложить проксимальный анастомоз аутовены с синтетическим протезом по типу «конец в бок».

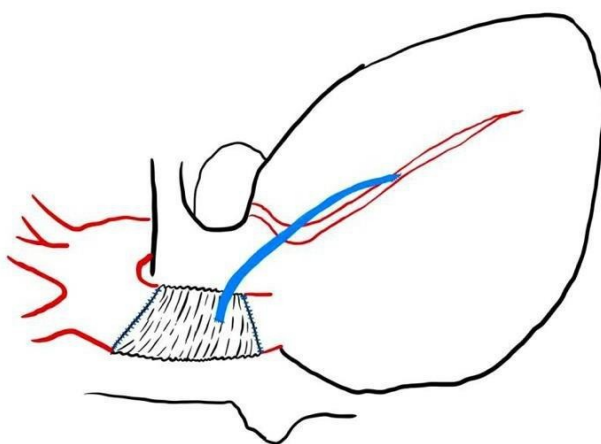
- Аневризмэктомия (резекция аорты в пределах здоровых тканей). Сформировать дистальный анастомоз между протезом и аортой проксимальнее БЦС «конец в конец». Из-за несоответствия диаметров аорты и протеза анастомоз формируется под углом;



- Сформировать проксимальный анастомоз между сосудистым протезом и аортой «конец в конец» также под углом;



- Сформировать проксимальный анастомоз между аутовеной и синтетическим протезом по типу «конец в бок» якорным или парашютным способом под углом 45–60° (дистальный анастомоз между аутовеной и коронарной артерией уже сформирован);



Рекомендуемые инструменты:

- Зажим Сатинского (1 шт.);
- Зажим по типу «бульдог» (1 шт.);
- Пинцет сосудистый (2 шт.);
- Иглодержатель сосудистый (1 шт.);
- Ножницы сосудистые (1 шт.);
- Скальпель остроконечный (1 шт.);
- Зажим Холстеда по типу «москит» с сегментами микроирригатора на браншах для фиксации шовного материала.

Описание препарата: Фиксированный макропрепарат в контейнере (имитация грудной полости). Муляж сердца. Синтетический протез INTERGARD 18 мм. Биологический материал: аорта свиная, кондуит из большой подкожной вены.

Рекомендуемый шовный материал:

- Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал с двумя атравматическими колющими иглами (Prolene, Монофил) USP 4/0 – 2 шт.;
- Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал с двумя атравматическими колющими иглами (Prolene, Монофил) USP 6/0 – 1 шт.

Время выполнения:

- Для получения максимального количества баллов по критерию «Время выполнения» конкурсное задание необходимо закончить за 80 минут;
- Стоп-время – 100 минут.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Слаженность работы бригады, соблюдение асептики и антисептики правильность работы с инструментами, техника работы с тканями	3 балла	Соблюдение критерия;
		0 баллов	Несоблюдение критерия;
2	Время выполнения	3 балла	Команда уложилась до 80 минут;
		2 балла	Команда уложилась до 90 минут;
		1 балл	Команда уложилась до 100 минут;
		0 баллов	Остановка конкурсного задания при превышении лимита времени (100 минут и более);

Дистальный анастомоз «конец-в-конец» между сосудистым протезом и аортой

3	Эстетичность сформированного анастомоза: • равномерно наложенные стежки; • отсутствие перекрестов нитей; • отсутствие провисания нитей; • отсутствие прорезывания нитей.	+ 1 балл	За каждый соблюденный критерий (от 0 до 4 баллов) ;
4	Герметичность	3 балла	Отсутствие струйного и диффузного истечения жидкости из линии анастомоза;
		2 балла	Диффузное просачивание из всей линии анастомоза;
		0 баллов	Струйное истечение из анастомоза;
5	Технические ошибки при наложении анастомоза (прорезывание нитей, попадание соединительной или жировой ткани в анастомоз)	3 балла	Замечаний нет;
		2 балла	Нет грубых нарушений, незначительные технические ошибки;
		0 баллов	Грубые технические ошибки, из-за которых значительно увеличится риск послеоперационных осложнений;

Проксимальный анастомоз «конец-в-конец» между сосудистым протезом и аортой			
6	Эстетичность сформированного анастомоза: • равномерно наложенные стежки; • отсутствие перекрестов нитей; • отсутствие провисания нитей; • отсутствие прорезывания нитей.	+ 1 балл	За каждый соблюденный критерий (от 0 до 4 баллов) ;
7	Герметичность	3 балла	Отсутствие струйного и диффузного истечения жидкости из линии анастомоза;
		2 балла	Диффузное просачивание из всей линии анастомоза;
		0 баллов	Струйное истечение из анастомоза;
8	Технические ошибки при наложении анастомоза (прорезывание нитей, попадание соединительной или жировой ткани в анастомоз)	3 балла	Замечаний нет;
		2 балла	Нет грубых нарушений, незначительные технические ошибки;
		0 баллов	Грубые технические ошибки, из-за которых значительно увеличится риск послеоперационных осложнений;

Анастомозы «конец-в-бок» между аутовеной и протезом

9	Эстетичность сформированного анастомоза: • равномерно наложенные стежки; • отсутствие перекрестов нитей; • отсутствие провисания нитей; • отсутствие прорезывания нитей.	+ 1 балл	За каждый соблюденный критерий (от 0 до 4 баллов) ;
10	Герметичность	3 балла	Отсутствие струйного и диффузного истечения жидкости из линии анастомоза;
		2 балла	Диффузное просачивание из всей линии анастомоза;
		0 баллов	Струйное истечение из анастомоза;
11	Технические ошибки при наложении анастомоза (прорезывание нитей, попадание соединительной или жировой ткани в анастомоз)	3 балла	Замечаний нет;
		2 балла	Нет грубых нарушений, незначительные технические ошибки;
		0 баллов	Грубые технические ошибки, из-за которых значительно увеличится риск послеоперационных осложнений;

Теория			
12	Теоретические вопросы	3 балла	3 правильных ответа;
		2 балла	2 правильных ответа;
		1 балл	1 правильный ответ;
		0 баллов	Команда не дала правильных ответов;
Максимальное количество баллов			39 баллов

Ответственные за конкурс:

- Попов Никита, <https://vk.ru/neropo17>;
- Вавилов Данила, <https://vk.ru/vavilov.danila>.

«Торакальная хирургия»

Ситуационная задача:

Клиническая ситуация: пациент, 9 лет, экстренно госпитализирован с выраженной инспираторной одышкой и явлениями стридора (сатурация при поступлении — 80%).

Анамнез: месяц назад выписан из хирургического стационара, где находился на лечении по поводу гангренозно-перфоративного аппендицита, осложнённого разлитым гнойным перитонитом. В послеоперационном периоде проводилась искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) в течение 11 суток. После стабилизации состояния ребёнок был успешно деканулирован и выписан.

Инструментальные исследования:

- СКТ органов грудной клетки: сужение просвета трахеи на уровне Th1 до 0,4 см на протяжении 1,5 см за счёт утолщения её стенок;
- Ригидная трахеоскопия: выполнено бужирование трахеи тубусами ригидного бронхоскопа. В дальнейшем бужирование проводилось ещё трижды в связи с кратковременным эффектом и рестенозом с признаками трахеомалации.

Учитывая неэффективность бужирования и рестенозирование трахеи, мультидисциплинарный врачебный консилиум определил показания к циркулярной резекции трахеи.

Диагноз: рубцовый стеноз трахеи, посттрахеостомический (после длительной ИВЛ), циркулярное сужение на уровне Th1, степень сужения — III.

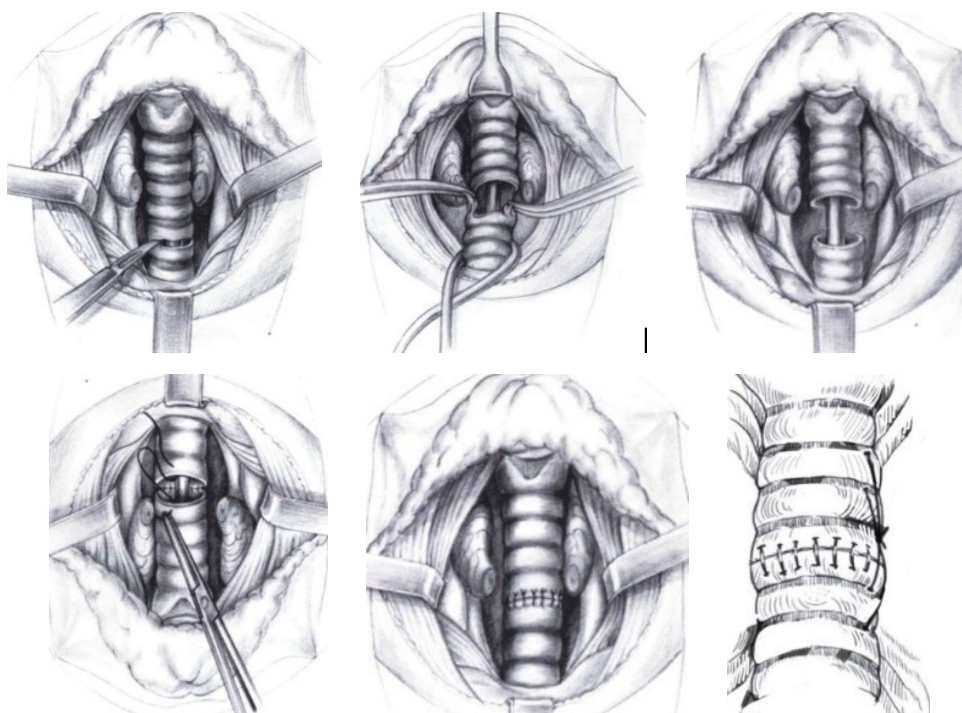
Конкурсное задание:

Команде необходимо выполнить **циркулярную резекцию трахеи** в пределах здоровых тканей (патологический участок будет отмечен организаторами конкурса):

- Отступя на 1,5 см от границ предполагаемых краниального и каудального разрезов трахеальной стенки, накладывают по две держалки из прочных нитей на атравматичной игле. Швы-держалки необходимы для сближения концов трахеи после циркулярной резекции, а также для контроля

положения трахеи в операционном поле во время наложения основных швов;

- Держалки накладывают, не проникая в просвет дыхательных путей и не захватывая слизистую оболочку;
- Пересечение трахеи производят острым скальпелем по межтрахеальным промежуткам. Допустимо делать разрез по хрящевым полукольцам при условии, что хрящ при сшивании не окажется в интерпозиции сшиваемых тканей;
- На края трахеотомического дефекта накладывают зажимы, подтягивая за которые открывают просвет дыхательного пути, что облегчает выполнение циркулярной резекции;
- Анастомоз начинают с задней стенки: на мембранозную часть трахеи накладывают непрерывный обвивной шов;
- Переднюю стенку сшивают отдельными сближающими швами с захватом хрящевых полуколец: сначала накладывают все швы, берут их на держалки, затем поочерёдно завязывают. Допустимо сшивание передней стенки непрерывным обвивным швом. Выбор техники шва команда обосновывает.



Описание препарата: манипуляция будет выполняться на трахее, уложенной в макет. Макет представляет собой пластиковую бутылку с вырезанным окном длиной 5–7 см, которое имитирует операционный доступ. Изнутри бутылка выстлана поролоном, концы трахеи зафиксированы. Макет установлен на подставку из пеноплекса. Участок стеноза протяжённостью 2 кольца трахеи будет отмечен организаторами.

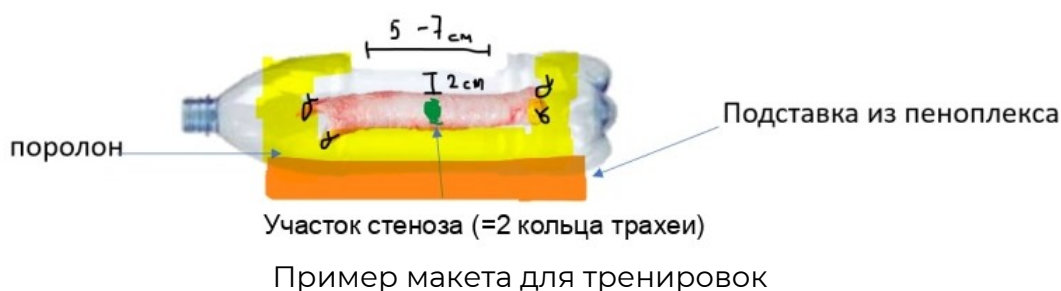


Фото макета

Рекомендуемые инструменты:

- Скальпель (1 шт.);
- Иглодержатель (1 шт.);
- Пинцет анатомический (2 шт.);
- Зажим Бильрот (2 шт.);
- Зажим типа «москит» (4 шт.).

Рекомендуемый шовный материал:

- Викрил или PDS USP 2/0–3/0 на атравматичной игле (3 шт.).

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра.

Время выполнения:

- Время выполнения конкурса — 60 минут;

- Стоп-время — 75 минут. После окончания времени операция считается завершённой, команды прекращают дальнейший ход операции.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Герметичность	2 балла	Анастомоз герметичен, пузырьки воздуха не пропускаются;
		1 балл	Пропускание мелких единичных пузырьков воздуха по линии шва;
		0 баллов	Пропускание крупных пузырей по линии шва;
2	Эстетичность	2 балла	Одинаковые промежутки между стежками, одинаковое направление швов, отсутствие прорезывания стенки трахеи;
		1 балл	Неполное соблюдение критериев (стежки разнонаправленные или стенка трахеи прорезалась);
		0 баллов	Полное несоблюдение критериев (стежки разнонаправленные и стенка трахеи прорезалась);
3	Соблюдение методики наложения шва	2 балла	Концы трахеи сопоставлены, в просвете нет узлов;
		1 балл	Концы трахеи сопоставлены, в просвете единичный узел;
		0 баллов	Концы трахеи не сопоставлены, хрящ в интерпозиции сшиваемых тканей, в просвете видны 2 и более узлов;

4	Наличие швов-держалок и правильность их наложения	2 балла	Все швы-держалки наложены, в местах их наложения нитей в просвете трахеи нет;
		1 балл	Держалки наложены не в полном количестве либо в просвете трахеи виден единичный узел в месте наложения держалки;
		0 баллов	Швы-держалки не наложены или в просвете видны 2 и более узлов в местах их наложения;
5	Правильность положения трахеи после завершения операции	1 балл	Трахея расположена анатомически правильно;
		0 баллов	Несоблюдение критерия (перекрут трахеи);
6	Слаженность работы бригады, соблюдение правил асептики и антисептики, правильность работы с инструментами, техника работы с тканями	2 балла	Соблюдение всех критериев;
		0 баллов	Несоблюдение хотя бы одного из критериев;
7	Регламент времени	3 балла	Команда уложилась в 30 минут;
		1 балл	Команда уложилась в 60 минут;
		0 баллов	Команда не уложилась в 60 минут (75 минут — стоп-время);
Теория			
8	Теоретические вопросы (всего 4)	1 балл	За каждый правильный ответ в полном объеме;
		0,5 балла	За каждый правильный, но неполный ответ;



		0 баллов	Неправильный ответ;
Максимальное количество баллов			18 баллов

Ответственный за конкурс:

- Ахмедова Малика, https://vk.ru/by_miracle.



«Наложение сухожильного шва»

Ситуационная задача: пациент 35 лет доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение с жалобами на боли в области раны нижней трети голени правой ноги, нарушения сгибания стопы.

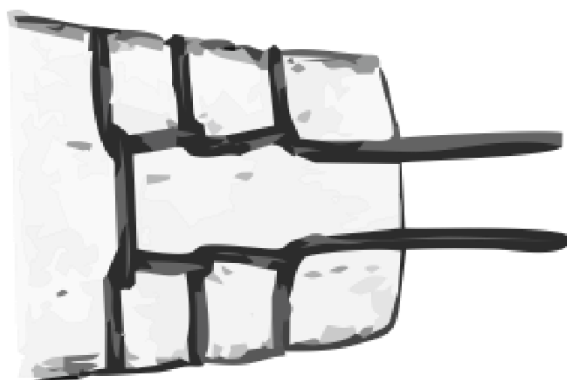
Из анамнеза следует, что 40 минут назад получена травма (порез) стеклом в области нижней трети голени правой ноги.

Общее состояние: удовлетворительное, АД – 130/90, пульс – 96, температура 36,8.

Объективно: при осмотре наблюдается разрез мягких тканей, повреждение ахиллова сухожилия.

Пациент был перенаправлен в операционную. На первом этапе было остановлено кровотечение, повреждение магистральных сосудов не обнаружено.

Конкурсное задание: участникам необходимо выполнить **шов ахиллова сухожилия** по одной из предложенных методик: Savage, CLC, Tsuge, Kessler, Krackow. Перед проведением операции команде необходимо обосновать выбор методики, обозначить требования к наложению сухожильного шва.



Описание препарата: бычье сухожилие.

Рекомендуемый инструментарий:

- Зажим типа Москит (2 шт.);
- Скальпель брюшистый (1 шт.);
- Игла травматическая (мин. 1 шт.);
- Иглодержатель (1 шт.);
- Пинцет анатомический (1 шт.);
- Пинцет хирургический (1 шт.).

Рекомендуемый шовный материал:

- Лавсан/капрон/этибонд USP 1 – 2 шт., монофил USP 4/0 – 1 шт.

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра.

Время выполнения:

- 50 минут.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
1	Обеспечение хорошего обзора концов поврежденного сухожилия	2 балла	Выполнение критерия;
		1 балл	Выполнение критерия с негрубыми недостатками;
		0 баллов	Невыполнение критерия;
2	Обращение с сухожилием (отсутствие выраженного разволокнения, расщепления сухожильных волокон, сохранение правильной анатомической формы сухожилия)	3 балла	Выполнение критерия;
		2 балла	Соблюдены 2 из 3 критериев;
		1 балл	Соблюдён 1 из 3 критериев либо имеются множественные погрешности во всех критериях;
		0 баллов	Невыполнение критерия;
3	Применение адаптационных швов	2 балла	Выполнение критерия;
		1 балл	Выполнение критерия с негрубыми недостатками;
		0 баллов	Невыполнение критерия;
4	Эстетичность шва (соблюдение аккуратности выполнения шва, ровного шага, симметричности наложения стежков)	3 балла	Выполнение критерия;
		1 балл	Выполнение критерия с негрубыми недостатками;
		0 баллов	Невыполнение критерия;
5		3 балла	Нет диастаза;

	Диастаз сухожилия в области шва на растяжение при нагрузке до 10 кг	2 балла	Диастаз до 2 мм;
		1 балл	Диастаз до 4 мм;
		0 баллов	Диастаз более 4 мм;
6	Слаженность работы бригады, соблюдение асептики и антисептики правильность работы с инструментами, техника работы с тканями	2 балла	Соблюдение критерия;
		0 баллов	Несоблюдение критерия;
7	Время выполнения	2 балла	Команда закончила до 50 минут;
		0 баллов	Команда закончила от 50 минут и более;
Максимальное количество баллов			17

При наличии одинаковых баллов за конкурс приоритет отдается команде, выполнившей задание **за меньшее время**.

Ответственные за конкурс:

- Гунзынов Дамдин, <https://vk.ru/gunzynator>;
- Бегадилла Бекарыс, https://vk.ru/child___of___prophecy.

«Реконструктивно-пластическая хирургия. Первый этап»

Ситуационная задача: пациентка А., 43 лет, после радикальной мастэктомии по Madden по поводу рака молочной железы и последующей двухэтапной реконструкции молочной железы с помощью экспандера и имплантата. Пациентке показана реконструкция сосково-ареолярного комплекса (САК).

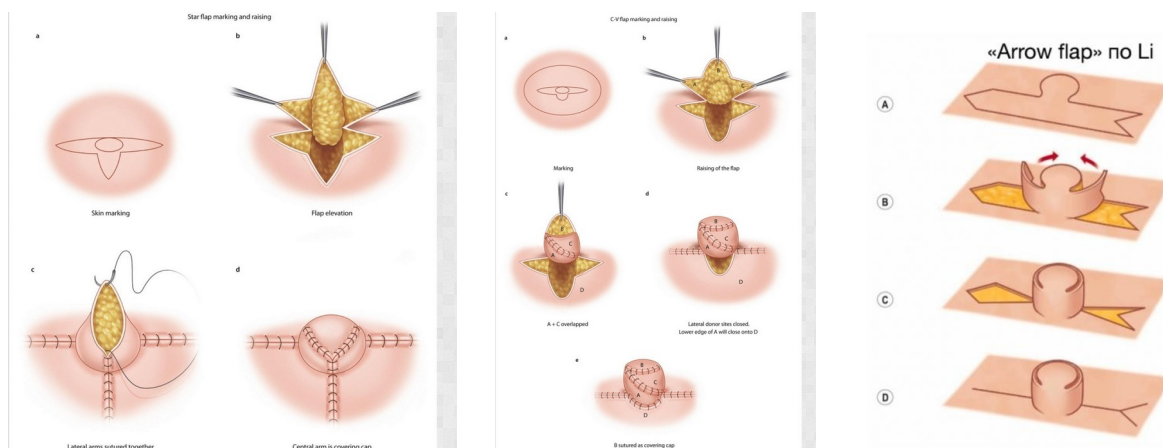
Конкурсное задание: команде необходимо **восстановить сосково-ареолярный комплекс** на одной из моделируемых сторон по одной из предложенных методик:

- «Arrow» flap (по Li);
- CV-flap;
- Star flap (по Shestak).

Ход операции:

- Нанести разметку, соответствующую выбранному лоскуту;
- Выполнить реконструкцию САК выбранным лоскутом.

Швы и способ формирования узлов команда выбирает самостоятельно и обосновывает. Использование механических сшивающих аппаратов (степлеров, кожных скрепок) и кожного клея исключается.



Описание препарата: конкурс будет проводиться на кожном лоскуте спинки куриной тушки. Параметры толщины ПЖК и мышечного слоя могут быть разными в зависимости от препарата. До начала конкурса будет проведена жеребьёвка для распределения кожных лоскутов между командами. Ожидаемый диаметр соска — 0,8 см (измеряется по основанию получившегося соска), высота соска — 0,5–1 см. При значительном отклонении диаметра соска (менее 0,5 или более 1,2 см) будут вычтены баллы за эстетичность.

Рекомендуемые инструменты:

- Иглодержатель (1 шт.);
- Пинцет анатомический (4 шт.);
- Ножницы (1 шт.);
- Скальпель (1 шт.);
- Сантиметровая лента;
- Маркер.

Рекомендуемый шовный материал:

- Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал на атравматической колющей игле (PROLENE, МОНОФИЛ), USP 4/0;
- Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал на атравматической колющей игле (PROLENE, МОНОФИЛ), USP 5/0.

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра. Расположение команды относительно препарата может быть переменным.

Время выполнения:

- 30 минут.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Выживаемость	4 балла	Наиболее вероятная выживаемость соска;
		0 баллов	При аргументированных сомнениях судей в выживаемости соска команда получает 0 баллов за критерий 1, а критерии 2, 3 и 4 аннулируются;

2	Эстетичность	5 баллов	Равномерные промежутки между стежками, отсутствие «гармошек», стягиваний и других деформаций, точное соблюдение техники операции;
		3 балла	Равномерные промежутки между стежками, неравномерное затягивание узлов, отсутствие «гармошек», стягиваний, деформация краёв, соблюдение техники операции;
		1 балл	Неравномерные промежутки между стежками, неравномерное затягивание узлов, наличие «гармошек», стягиваний и других деформаций, соблюдение техники операции;
		0 баллов	Неравномерные промежутки между стежками, неравномерное затягивание узлов, наличие «гармошек», стягиваний и других деформаций, несоблюдение техники операции;
		-3 балла	При значительном отклонении диаметра соска от планируемого (менее 0,5 или более 1,2 см) отнимается 3 балла из общей суммы;
3	Точность сопоставления краёв раны	4 балла	Точная адаптация одноимённых краёв раны;
		2 балла	Смещение этажности (сопоставление и сшивание разных слоёв) на одном участке раны;

		1 балл	Смещение этажности (сопоставление и сшивание разных слоёв) на нескольких участках раны;
		0 баллов	Полное несоответствие краёв кожи и ПЖК на всём участке ушиваемой раны;
4	Отсутствие «карманов» / полостей	2 балла	Отсутствие «карманов» в ПЖК и на коже;
		1 балл	Отсутствие «карманов» только в ПЖК;
		0 баллов	Наличие видимых «карманов»;
5	Слаженность работы бригады	1 балл	Правильная подача инструментов, слаженное взаимодействие между членами бригады;
		0 баллов	Грубые нарушения при работе, влияющие на ход операции;
6	Время выполнения	3 балла	До 30 минут;
		1 балл	До 35 минут;
		0 баллов	Более 35 минут;
Теория			
7	Теоретическая подготовка	1–3 балла	Знание анатомии и физиологии молочной железы;
		1 балл	Знание техники и хода оперативного вмешательства;
Максимальное количество баллов			22 балла

При наличии одинаковых баллов за конкурс приоритет отдаётся команде, выполнившей задание **за меньшее время**.

Ответственные за конкурс:

- Грибанова Белла, [https://vk.ru/two___pm](https://vk.ru/two___pm;);
- Имтоссими Георгий, <https://vk.ru/g.imtossimi>.

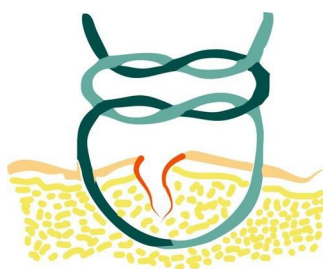


«Вязание хирургических узлов»

Конкурсное задание: в конкурсе участвуют все три участника команды. Каждому участнику по очереди необходимо за 30 секунд завязать наибольшее количество качественных узлов в медицинских перчатках нитью на пальце представителя оргкомитета. Первый узел фиксируется отдельно и в конкурсное время не входит. Необходимо завязывать прямые узлы. Завязывание узлов приемлемо любым хирургическим методом. Также необходимым условием является плотное завязывание узлов (не пропускать конец зубочистки более 1 мм). Результат команды — сумма длин «косичек» всех трёх участников.

Необходимый расходный материал: медицинские перчатки.

Необходимый шовный материал: полифиламентный шовный материал (капрон), размер USP 1, длина 60 см.



№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Длина «косички»	1 балл	За каждый 1 см (неполный сантиметр засчитывается пропорционально);
2	Наличие неправильных (непрямых) узлов	– 0,1 балла	За каждый неправильный узел;
3	Наличие неплотно завязанных узлов (пропускает зубочистку более чем на 1 мм)	– 0,1 балла	За каждый неплотный узел;

Ответственный за конкурс:

- Бабина Кристина, https://vk.ru/kri_bn.



ВТОРОЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ

**КОНКУРСЫ ТУРА: «Травматология»,
«Оперативная урология», «Реконструктивно-
пластическая хирургия. Второй этап»,
«Оперативная гинекология».**

7 НОЯБРЯ 2026



ТОМСК, 2026

ОПИСАНИЕ КОНКУРСОВ ВТОРОГО ТУРА

«Травматология»

Ситуационная задача:

Клиническая ситуация: в травмпункт «МСЧ № 2» доставлен пациент С., 72 лет, с жалобами на интенсивную боль, выраженную деформацию и ограничение движений в области левого лучезапястного сустава. Травма получена 1 час назад при падении на вытянутую руку с упором на ладонь во время гололеда.

Объективный статус: общее состояние средней тяжести, сознание ясное.

Гемодинамика стабильна: АД 140/85 мм рт. ст., ЧД 18/мин, ЧСС 90 уд/мин, SatO₂ 98%.

Локально: левая кисть отечна, выраженная штыкообразная деформация в дистальном отделе предплечья. Кожные покровы гиперемированы, гематома в проекции лучезапястного сустава. Пальпация резко болезненна, крепитация отломков. Активные и пассивные движения невозможны из-за боли. Пульсация на лучевой артерии сохранена, чувствительность дистальнее места перелома не нарушена.

Конкурсное задание:

- Участникам предлагается продемонстрировать правильную технику **закрытой репозиции костных отломков с последующим наложением гипсовой повязки;**
- Описать рентгенологические критерии правильной репозиции.

Рекомендуемый инвентарь:

Гипсовые бинты (ширина 15 см) – 2 шт., марлевые салфетки, ножницы, емкость для воды, бинт марлевый нестерильный – 2 шт., ватные прокладки, шприц.

Операционная бригада: в конкурсе принимает участие вся команда, самостоятельно решая вопрос о функциях каждого, в том числе кто из участников будет пострадавшим.

Время выполнения:

15 минут + 5 минут на обсуждение рентгенограмм.



Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Подготовка необходимого инвентаря	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
2	Проверка качества гипсового бинта (крепкое сжатие гипсового бинта кулаком; если гипсовый бинт хорошего качества, то после разжатия кулака гипс с бинта рассыпается; в случае плохого качества — на гипсовом бинте останутся вдавления, конгруэнтные пальцам; гипс, смешанный с водой, не должен иметь постороннего запаха, например тухлых яиц и др.)	2 балла	Выполнено;
		1 балл	Незначительные дефекты;
		0 баллов	Гипсовый бинт непригоден;
3	Подготовка пациента (усаживание, принятие правильного положения конечности)	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
4	Обезболивание (имитация)	1 балл	Выполнено;

	гематомной блокады 0,5% р-ом новокаина)	0 баллов	Не выполнено;
5	Техника репозиции (тракция, сгибание, давление на дистальный отломок)	5 баллов	Анатомическое восстановление;
		3 балла	Неполная репозиция;
		0 баллов	Неудача;
6	Фиксация 2 суставов (лучезапястный, пястно-фаланговые)	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
7	Подготовка кожных покровов к наложению гипсовой повязки (наложение «сухой» лонгеты)	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
8	Защита костных выступов ватными прокладками	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
9	Наложение гипсовой лонгеты (от головок пястных костей до верхней трети предплечья)	2 балла	Выполнено правильно;
		1 балл	Незначительные ошибки;
		0 баллов	Выполнено неправильно;
10	Загибы проксимального и дистального краёв повязки	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
11	Положение кисти (10–15° ладонного сгибания, 15° локтевого отклонения)	3 балла	Выполнено;
		1 балл	Выполнено с незначительными нарушениями;
		0 баллов	Не выполнено;
12	Циркулярная бинтовая повязка	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;

13	Контроль кровоснабжения (температура, цвет кожи, пульс)	1 балл	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
14	Постановка диагноза	5 баллов	Полно и точно;
		2 балла	Частично;
		0 баллов	Неверно;
15	Описание рентгенологических критериев успешной репозиции	5 баллов	Полно и точно;
		2 балла	Частично;
		0 баллов	Неверно;
16	Слаженность работы команды	3 балла	Отлично;
		1 балл	Удовлетворительно;
		0 баллов	Плохо;
17	Соблюдение временного регламента (20 мин)	2 балла	Выполнено;
		0 баллов	Не выполнено;
Максимальное количество баллов			36

Ответственные за конкурс:

- Ибрагимов Фазли, <https://vk.ru/ibragimov.fazli>;
- Гунзынов Дамдин, <https://vk.ru/gunzynator>.

«Оперативная урология»

Ситуационная задача:

Клиническая ситуация: пациентка, 30 лет, жалуется на постоянное нарушение мочеиспускания, боль в левой подвздошной области.

Анамнез: в 2010 году несколько сеансов дистанционной литотрипсии по поводу конкремента средней трети левого мочеточника. Диагностирована стриктура средней трети левого мочеточника протяженностью 4 см. В 2010–2012 гг. множественные эндоскопические вмешательства: бужирования мочеточника, уретеротомия «холодным» ножом. Неоднократное стентирование мочеточника J-J стентом, на фоне которого возникал пузырно-мочеточниковый рефлюкс, частые атаки пиелонефрита. При установке антирефлюксного стента – функция дренажа неадекватная.

Рекомендовано оперативное лечение в объеме субтотальной пластики левого мочеточника пузырным лоскутом по Боари.

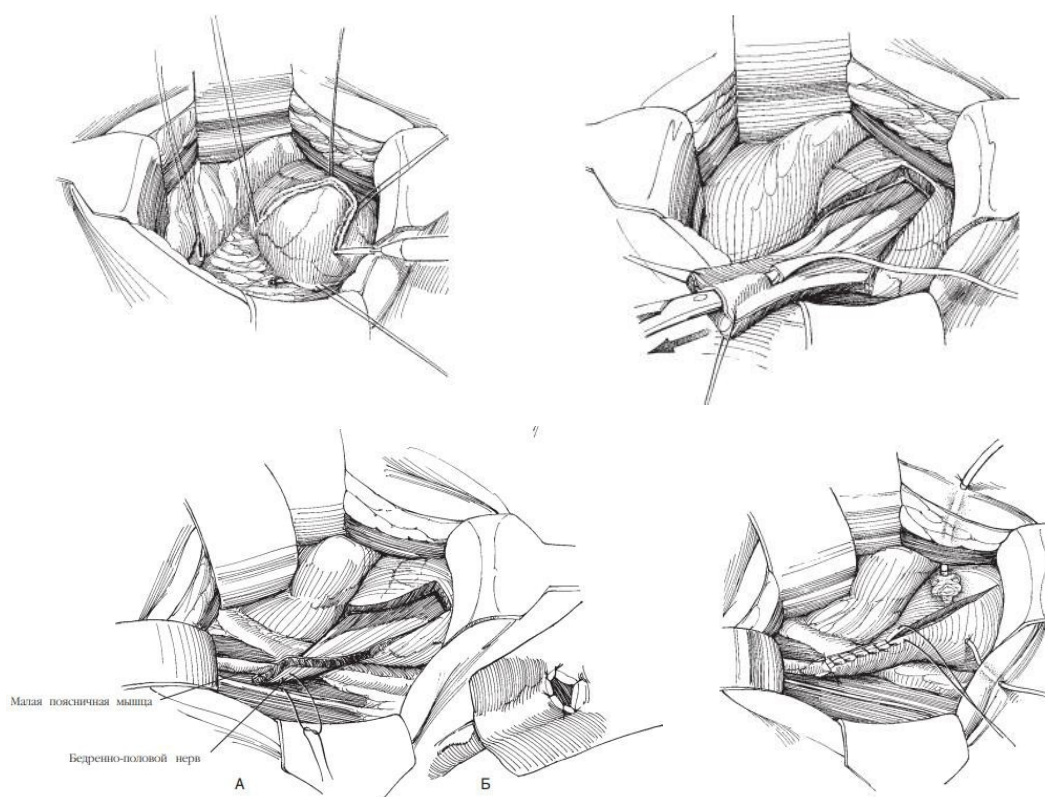
Конкурсное задание:

Команде необходимо выполнить **операцию Боари в модификации Psoas-Hitch** (реконструкция мочеточника лоскутом мочевого пузыря с фиксацией к поясничной мышце), совершив следующие этапы:

- Необходимо лигировать и пересечь мочеточник, который далее будет использоваться в качестве дистального отдела неповрежденного мочеточника;
- Производится выкраивание поперечного лоскута из верхушки мочевого пузыря 5–7 см на 2 см с основанием в области верхушки или задней стенки мочевого пузыря;
- Лоскут перемещается к культе мочеточника, без натяжения;
- Формируют не прямой уретероцистоанастомоз узловыми или непрерывными швами (USP 5/0) по антирефлюксной методике;
- В мочеточник до лоханки вводится мочеточниковый катетер, наружный конец которого выводят через мочеиспускательный канал;
- Конец лоскута фиксируют к поясничной мышце (монофил 4/0);



- Конец мочеточника фиксируют к внутренней поверхности лоскута;
- После завершения анастомоза из лоскута формируют трубку, первый ряд — слизистый, непрерывным швом от шейки пузыря к периферии до плотного сближения краев лоскута (USP 4/0);
- Второй ряд – узловый или непрерывный шов серозно-мышечного слоя (USP 3/0). Следует внимательно следить за состоянием лоскута: узость лоскута или его чрезмерное натяжение приводят к ишемии, что обрекает операцию на неудачу;



Описание препарата:

Мочевой пузырь с уретрой и одним мочеточником, куриное бедро (имитация m. psoas).

Рекомендуемые инструменты:

- Скальпель (1 шт.);
- Иглодержатель общехирургический (1 шт.);
- Пинцет анатомический (2 шт.);
- Ножницы (1 шт.);

- Зажим Холстеда по типу «москит» прямой (1 шт.).

Рекомендуемый шовный материал:

- Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с одной атравматической колющей иглой USP 5/0 – 1 шт.;
- Полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с одной атравматической колющей иглой USP 3/0 – 2 шт.;
- Полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с одной атравматической колющей иглой USP 4/0 – 2 шт.;
- Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал на атравматической колющей игле (PROLENE, МОНОФИЛ), USP 4/0 – 1 шт.

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра.

Время выполнения:

- Время выполнения – 60 минут;
- Будут начисляться дополнительные баллы за время выполнения по формуле: количество бонусных баллов = $(10 - N) \times 0,15$, где N – распределение команды по времени выполнения конкурса. Например, команда, сделавшая конкурс быстрее остальных, получает $(10 - 1) \times 0,15 = 1,35$ бонусных балла. Команда, завершившая конкурс со вторым результатом по времени, получает $(10 - 2) \times 0,15 = 1,2$ бонусных балла, и так далее.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Подготовка зоны операции	2 балла	Стенка мочевого пузыря и мочеточник выделены полностью;
		1 балл	Имеются замечания по одному из этапов подготовки;
		0 баллов	Подготовка выполнена не в полном объеме;



2	Эстетичность	2 балла	Одинаковые промежутки между стежками, равномерное затягивание стежков, равное направление стежков;
		1 балл	Различные промежутки между стежками, одинаковое направление стежков, неравномерное затягивание;
		0 баллов	Различные промежутки между стежками, разное направление стежков, неравномерное затягивание стежков;
3	Герметичность уретероцисто-анастомоза (проверяется путем введения катетера в просвет резервуара через уретру и нагнетания стандартного объема воды (150 мл) шприцом Жане под давлением)	4 балла	Герметичный анастомоз (нет подтекания и просачивания жидкости);
		2 балла	Капельное просачивание жидкости;
		0 баллов	Отсутствие герметичности линии шва (струйное, диффузное подтекание из линии шва);
4	Герметичность мочевого пузыря	4 балла	Герметичный анастомоз (нет подтекания и просачивания жидкости);
		2 балла	Капельное просачивание жидкости;
		0 баллов	Отсутствие герметичности линии шва;
5	Отсутствие стенозирования просвета анастомоза (проверяется после	3 балла	Достаточная проходимость анастомоза (жидкость из мочеточника вытекает струйно, не задерживается);

	завершения конкурса при помощи введения мочеточникового катетера) – после удаления установленных ранее катетеров	2 балла	Незначительное сужение просвета (жидкость из мочеточника вытекает частыми каплями);
		1 балл	Значительное сужение просвета (жидкость из мочеточника вытекает редкими каплями);
		0 баллов	Полная непроходимость мочеточника (жидкость не вытекает из мочеточника);
6	Использование антирефлюксной методики имплантации мочеточника	2 балла	Отсутствие рефлюкса;
		0 баллов	Наличие рефлюкса;
7	Время выполнения конкурса	3 балла	До 45 минут;
		2 балла	До 50 минут;
		1 балл	До 60 минут;
		0 баллов	Более 60 минут (остановка конкурса свыше 70 минут);
8	Слаженность работы бригады, соблюдение асептики и антисептики правильность работы с инструментами, техника работы с тканями	1 балл	Соблюдение критерия;
		0 баллов	Несоблюдение критерия;
9	Фиксация лоскута к имитации m. psoas	2 балла	Полная фиксация, эстетичность и функциональность швов;
		1 балл	Частичное прорезывание швов, число фиксирующих узлов/стежков менее трёх;
		0 баллов	Отсутствие фиксации;
10		1 балл	Полное соответствие;

	Соответствие размеров и расположения лоскута условиям конкурса	0 баллов	Малый размер лоскута, неправильное расположение лоскута;
Теория			
11	Теоретическая подготовка	2 балла	Все ответы верные;
		1 балл	Допущены ошибки;
		0 баллов	Все ответы неправильные;
Максимальное количество баллов за конкурс (без учета бонусных баллов за время)			26 баллов

Приоритетность критериев:

1. Герметичность;
2. Теория;
3. Время.

Ответственные за конкурс:

- Бакушина Софья, <https://vk.ru/sonyabakushina>;
- Абаимов Иван, <https://vk.ru/abaimovivan>.

«Реконструктивно-пластическая хирургия. Второй этап»

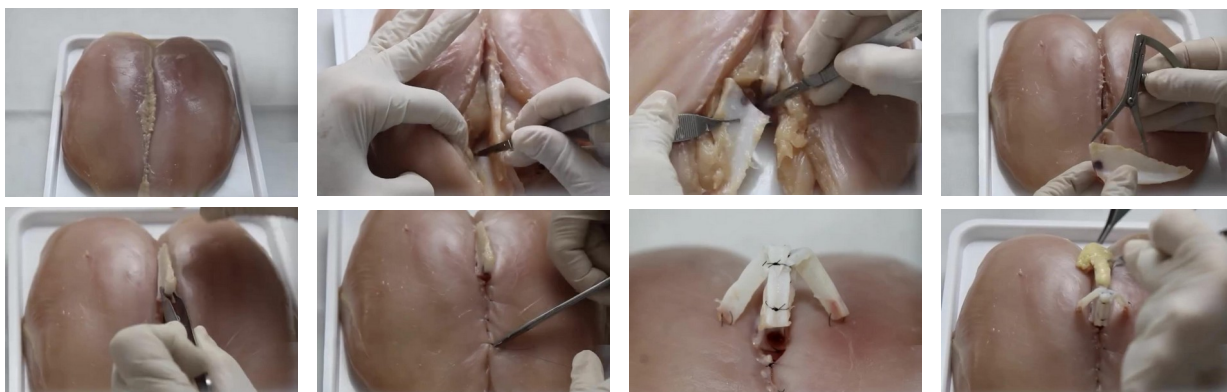
Конкурсное задание: команде необходимо выполнить симуляционную операцию по **полной реконструкции носовых структур** на модели из куриной грудки, воспроизведя основные этапы ринопластики:

- Создание опорных структур (имитация костно-хрящевого каркаса);
- Моделирование мягких тканей и кожи;
- Применение графтов;
- Формирование эстетически и функционально приемлемой формы носа.

Ход операции:

1. Отсепаровка кожи с куриной грудки;
2. Выделение и моделирование «костно-хрящевых» элементов;
3. Формирование из полученного хряща каркаса в виде перегородки носа и фиксация его к мягким тканям;
4. Подготовка хрящевых элементов и графтов для реконструкции, их фиксация к хрящевой опоре, формирование крыльев и кончика носа;
5. Создание объёма и формы носа с помощью тканей куриной грудки (жировой, мышечной);
6. Моделирование кожного покрытия, фиксация структур, формирование отверстий ноздрей.

Допускается вариативность техник внутри этапов (различные варианты графтов, способы фиксации), но обязательны логическая последовательность и обоснованность действий.





Описание препарата: куриная грудка с хрящевой частью грудины на лотке, накрытая влажной марлей.

Рекомендуемые инструменты:

- Иглодержатель (1 шт.);
- Пинцет анатомический (4 шт.);
- Ножницы (1 шт.);
- Скальпель (1 шт.);
- Сантиметровая лента;
- Маркер.

Рекомендуемый шовный материал:

- Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал на аatraumaticкой колющей игле (PROLENE, МОНОФИЛ), USP 4/0;
- Монофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал на аatraumaticкой колющей игле (PROLENE, МОНОФИЛ), USP 5/0.

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра. Расположение команды относительно препарата может быть переменным.

Время выполнения:

- 80 минут.

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Техника работы с тканями и инструментами	2 балла	Аккуратная диссекция, минимальная травматизация тканей, правильное использование инструментов;
		0 баллов	Нарушение техники диссекции, выраженная травматизация тканей, нарушения в технике использования инструментария;
2	Качество реконструкции	3–5 баллов	Симметрия, форма, устойчивость конструкции, соответствие анатомическим принципам строения носа;
		1–2 балла	Нарушена симметрия, но конструкция устойчивая;
		0 баллов	Нарушение симметрии, неустойчивая конструкция;
3	Использование графтов	1–3 балла	Грамотное применение графтов, оригинальность и обоснованность решений;
		0 баллов	Неадекватное применение графтов или их отсутствие;
4	Эстетический и функциональный результат	1–5 баллов	Эстетически приемлемый внешний вид, правдоподобие «носа»;
		0 баллов	Нарушены эстетические параметры;
5	Слаженность работы бригады	2 балла	Правильная подача инструментов, слаженное взаимодействие между членами бригады;

		0 баллов	Грубые нарушения при работе, влияющие на ход операции;
6	Время выполнения	3 балла	До 80 минут;
		1 балл	80–85 минут;
		0 баллов	Более 85 минут;
Теория			
7	Теоретическая подготовка	1–3 балла	Знание анатомии и физиологии области носа;
		1 балл	Знание техники и хода оперативного вмешательства;
Максимальное количество баллов			23 балла

При наличии одинаковых баллов за конкурс приоритет отдаётся команде, выполнившей задание **за меньшее время**.

Ответственные за конкурс:

- Грибанова Белла, https://vk.ru/two__pm;
- Имтоссими Георгий, <https://vk.ru/g.imtossimi>.

«Оперативная гинекология»

Ситуационная задача:

Клиническая ситуация: пациентка С., 35 лет, обратилась в гинекологическое отделение с жалобами на выделения из влагалища с неприятным каловым запахом, боли при половом акте.

Анамнез: роды 5 месяцев назад: крупный плод (4200 г), затяжной второй период, наложение акушерских щипцов. Разрыв промежности II степени. Менструальная функция не нарушена. Сопутствующих заболеваний нет.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Живот мягкий, безболезненный.

Гинекологический статус: наружные половые органы — рубцовая деформация промежности. При осмотре в зеркалах: слизистая влагалища гиперемирована, обильные слизистогнойные выделения. При бимануальном исследовании: матка и придатки без особенностей. При ректовагинальном исследовании: в нижней трети прямой кишки по передней стенке пальпируется щелевидное отверстие с плотными фиброзными краями, сообщающееся с влагалищем.

Лабораторные исследования:

- ОАК: Hb 118 г/л, лейкоциты $7,5 \times 10^9$ /л, СОЭ 15 мм/ч;
- Биохимический анализ крови, коагулограмма — в пределах нормы;
- Посев отделяемого из влагалища: обильный рост E. coli.

Инструментальные исследования:

- УЗИ органов малого таза: патологии матки и придатков не выявлено. При трансвагинальном УЗИ с контрастированием прямой кишки визуализируется линейный гипоэхогенный свищевой ход длиной 1,0 см, диаметром до 0,4 см, соединяющий просвет прямой кишки со средним отделом влагалища;
- Фистулография: подтверждён прямой ректовагинальный свищ протяжённостью 1,0–1,5 см, без разветвлений;
- Ректороманоскопия: на высоте 3 см от ануса по передней стенке определяется щелевидное свищевое отверстие



диаметром около 0,4 см, слизистая вокруг рубцовой изменена; выше — слизистая без особенностей.

Диагноз: прямой ректовагинальный свищ (послеродовый, низкий). Рубцовая деформация промежности. Хронический вульвовагинит.

Конкурсное задание: команде предлагается выполнить **пластику ректовагинального свища влагалищным доступом**, выполнив следующие этапы:

- Провести осмотр наружных половых органов;
- Провести ректальное исследование для поиска свищевого хода;
- Выполнить циркулярный разрез и препаровку тканей вокруг свищевого отверстия;
- Иссечь свищевой ход;
- Выполнить пластику дефекта стенки прямой кишки;
- Выполнить пластику фиброзно-мышечного слоя влагалища;
- Выполнить пластику слизистой оболочки влагалища.

Описание препарата: для имитации женской промежности используются два отрезка толстой или прямой кишки свиньи длиной 10–15 см: отрезок с более широким просветом имитирует влагалище, с более узким — прямую кишку. Отрезки уложены один на другой и зафиксированы по краю. Через соприкасающиеся стенки прямой кишки и «влагалища» на расстоянии 2–3 см от края сформировано сквозное отверстие, по периметру зафиксированное узловыми швами, — имитация свищевого хода. Комплекс фиксирован в тушке курицы, проходимость свищевого хода проверена.

Соответствие слоёв при выполнении операции:

- Слизистая кишки — слизистая влагалища;
- Мышечно-серозный футляр кишки — фиброзно-мышечный слой влагалища;
- Стенка прямой кишки — стенка прямой кишки.



Два отрезка кишки
свиньи длиной
10–15 см



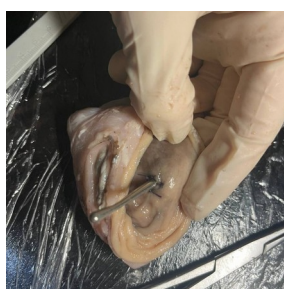
Отрезки уложены
один на другой



Отрезки
зафиксированы по
краю



Сквозное
отверстие в 2–3 см
от края



Свищевое
отверстие
зафиксировано
узловыми швами



Комплекс
фиксирован в
тушке курицы



Проверка
проходимости
свищевого хода

Рекомендованный инструментарий:

- Зеркало Куско (1 шт.);
- Крючки Фарабефа (2 шт.);
- Пуговчатый зонд (1 шт.);
- Скальпель № 10 (1 шт.);
- Ножницы Купера (1 шт.);
- Пинцеты анатомические (2 шт.);
- Зажим типа «москит» (1 шт.);
- Иглодержатель Гегара (1 шт.).

Рекомендуемый шовный материал:

- Полифиламентный рассасывающийся шовный материал (Vicryl, ПГА), USP 2/0 и 3/0.

Операционная бригада: 1 оператор, 1 ассистент, 1 операционная сестра.

Время выполнения:

- Для получения максимального количества баллов по критерию «Время выполнения» необходимо уложиться в 45 минут;
- При превышении 50 минут команда продолжает работу, но не получает баллов за критерий «Время выполнения».

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Этапность операции			
1	Препаровка тканей влагалища	2 балла	Мобилизация выполнена в достаточном объёме;
		1 балл	Мобилизация минимальна, ткани плохо отслоены;
		0 баллов	Мобилизация не выполнена;
2	Иссечение свищевого хода	2 балла	Свищевой ход иссечён полностью в пределах здоровых тканей;
		1 балл	Иссечение выполнено, но не радикально или с повреждением окружающих тканей;
		0 баллов	Свищевой ход не иссечён;
3	Пластика стенки прямой кишки	3 балла	Швы наложены на подслизистый/мышечный слой без проникновения в просвет, ряд герметичен и не вызывает стеноза просвета;
		2 балла	Ушивание выполнено, но с техническими погрешностями (проникновение в просвет, большие промежутки);
		1 балл	Шов негерметичен;
		0 баллов	Этап не выполнен;

4	Пластика фиброзно-мышечного слоя	3 балла	Фиброзно-мышечный слой ушит надёжно, полностью покрывает первый ряд швов, натяжение отсутствует;
		2 балла	Слой ушит, но покрытие неполное или есть умеренное натяжение;
		1 балл	Шов наложен некачественно, слой не сформирован;
		0 баллов	Этап пропущен;
5	Пластика слизистой влагалища	2 балла	Слизистая ушита аккуратно непрерывным или узловым швом, избыток иссечён, линия шва ровная, без натяжения;
		1 балл	Ушивание выполнено, но с дефектами (складки, неровные края);
		0 баллов	Этап не выполнен;
Общие критерии			
6	Аккуратность работы с тканями	2 балла	Повреждений нет либо есть незначительное повреждение, не влияющее на результат;
		1 балл	Множественные мелкие повреждения;
		0 баллов	Грубое повреждение, создание нового дефекта;
7	Правильная работа с инструментарием	1 балл	Соблюдение принципов аккуратной, безопасной и эффективной работы с инструментами;
		0 баллов	Нарушение безопасности работы, приводящее к травматизации органов и тканей;
8		1 балл	Соблюдение критерия;

	Слаженность работы членов операционной бригады	0 баллов	Нескоординированное взаимодействие между членами бригады, приводящее к нарушениям в выполнении оперативной техники;
9	Стерильность	1 балл	Участники работают в хирургических шапочках, костюмах, масках и перчатках; инструменты и шовный материал не поднимаются с пола во время конкурса;
		0 баллов	Критерий не соблюден;
10	Время выполнения	2 балла	Команда уложилась в 45 минут;
		1 балл	Команда уложилась в 50 минут;
		0 баллов	Более 50 минут;
Теория			
11	Теоретические вопросы	2 балла	Правильные ответы на 2 вопроса;
		1 балл	Правильный ответ на 1 вопрос;
		0 баллов	Нет правильных ответов;
Максимальное количество баллов			21 балл

При наличии одинаковых баллов за конкурс приоритет отдается команде, выполнившей задание **за меньшее время**.

Ответственные за конкурс:

- Устюжанина Ольга, https://vk.ru/u_olginay;
- Корнеева Алина, <https://vk.ru/akorneeva>.





ТРЕТИЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ

КОНКУРС ТУРА: «Сегментарная резекция толстой кишки с формированием анастомоза конец в конец на экспериментальном ЖИВОТНОМ».

8 НОЯБРЯ 2026



ТОМСК, 2026

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА ТРЕТЬЕГО ТУРА

«Сегментарная резекция толстой кишки с формированием анастомоза конец в конец на экспериментальном животном»

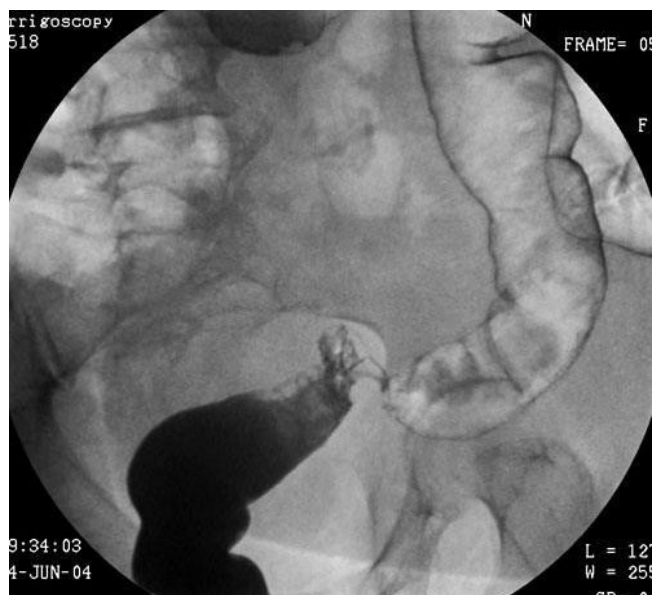
Ситуационная задача: в отделение общей хирургии ФГБОУ ВО СибГМУ госпитализирован больной К., 62 лет, для выполнения плановой операции по поводу рубцовой стриктуры сигмовидной кишки.

Анамнез: в настоящее время больного беспокоят частые запоры, вздутие и тяжесть в животе, иногда схваткообразные боли. Из анамнеза известно, что в ноябре прошлого года пациент перенес реконструктивную операцию по поводу функционирующей двуствольной сигмостомы, наложенной в 2017 году в связи с ранением прямой кишки. Течение послеоперационного периода после резекции колостомы осложнилось несостоятельностью анастомоза с последующим развитием рубцовой стриктуры сигмовидной кишки.

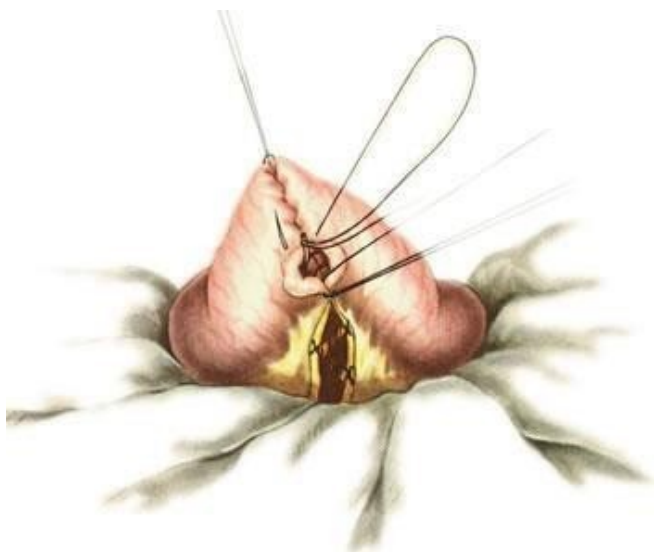
Инструментально:

- По данным колоноскопии на 45 см от ануса имеется циркулярная стриктура, стенозирующая просвет сигмовидной кишки до 10–12 мм. Колоноскоп провести за стриктуру не удалось. Взята биопсия;
- По данным гистологического исследования биопсийного материала признаки хронического воспаления в стенке кишки;
- Выполнена ирригоскопия: в области дистальной трети сигмовидной кишки имеется циркулярное сужение просвета протяженностью 7 мм. Стриктура не расправляется и с трудом пропускает жидкий контраст. Над стриктурой имеется супрастенотическое расширение ободочной кишки.





Конкурсное задание: бригадам предлагается смоделировать клиническую задачу на экспериментальном животном (кролике), выполнив под комбинированной анестезией сегментарную резекцию толстой кишки кролика с формированием анастомоза конец в конец одним из существующих способов анастомозирования, соблюдая принципы асептики и антисептики.



Подготовка к конкурсу: подготовка к оперативному вмешательству заключается в том, что экспериментальных животных ограничивают в приеме пищи за 12–18 часов до начала конкурса. Фиксацию животного и подготовку операционного поля бригады осуществляют самостоятельно. Для фиксации экспериментального животного будут предоставлены планки из ДСП с водоотталкивающим покрытием и отверстиями для проведения вязок, а также марлевые бинты для их изготовления. Экспериментальное

животное фиксируется в положении на спине за локтевые суставы (место соединения плечевой с лучевой и локтевой костями), а также за скакательные суставы (между голенью и костями плюсны). Для крепления конечностей рекомендуется использовать скользящую глухую петлю. После фиксации кролика приступают к бритью операционного поля в пределах рекомендуемых границ: сверху – основание мечевидного отростка и реберные дуги, снизу – лобковый симфиз, с боков – передние аксиллярные линии. Для подготовки операционного поля допускается использование механических и электрических устройств для стрижки животного.

Сбрита шерсть животного, ветошь, перчатки, использованные при подготовке животного к оперативному вмешательству, собираются членами бригады в мешок для утилизации медицинских отходов класса Б. Операционная бригада надевает операционные шапочки, маски и приступает к обработке рук. Операционная сестра, соблюдая правила асептики и антисептики, надевает операционный халат, перчатки, накрывает операционный стол, одевает оперирующего хирурга и ассистента. Бригада обрабатывает операционное поле антисептиком и фиксирует клеющую стерильную простыню на брюшную стенку экспериментального животного. По завершении анестезии бригады докладывают о готовности начать лапаротомию. Оперативное вмешательство проводится под ингаляционным наркозом.



Ход операции:

Бригадами выполняется срединная лапаротомия. Длина разреза — на усмотрение команды. Перед началом абдоминального этапа производится новокаиновая блокада брыжейки. В ходе оперативного вмешательства обязательна резекция не менее 4 см толстой кишки с лигированием пристеночных сосудов брыжейки, а также строгое соблюдение принципов асептики и антисептики. Межкишечный анастомоз формируется «конец в конец» одним из существующих способов ручного кишечного шва с обязательным ушиванием окна брыжейки. Ушивание операционной раны производится послойно. Работа с экспериментальным животным проводится под контролем практикующих врачей-хирургов. Время на выполнение конкурсного задания: 90 минут. Сигнал о начале операции при одновременной готовности команд. Бригады одновременно приступают к выполнению этапов операции. Время на секундомере фиксируется от начала разреза до завязывания последнего кожного шва.

Операционная бригада: 1 хирург, 1 ассистент, 1 операционная медицинская сестра, 1 санитар (санитар предоставляется от организаторов).

Рекомендованный инструментарий:

- Бельевые цапки для фиксации операционного белья (мин. 4 шт.);
- Корнцанг (мин. 1 шт.);
- Иглодержатель (мин. 1 шт.);
- Пинцеты анатомический и хирургический (мин. 2 шт.);
- Ножницы Купера/Метценбаума (мин. 2 шт.);
- Кишечный жом эластичный Кохера (мин. 2 шт.);
- Г-образный зажим для пищевода / бронхов (мин. 1 шт.);
- Скальпель (мин. 1 шт.);
- Зажим кровоостанавливающий Бильрота (мин. 2 шт.);
- Зажим кровоостанавливающий Кохера (мин. 2 шт.);
- Зажим кровоостанавливающий Холстеда по типу «москит» (мин. 2 шт.);

- Крючки (ранорасширители) Фарабефа (мин. 1 шт.);
- Зажим Микулича (мин. 4 шт.);

Расходный шовный материал:

- Полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал на атравматической колющей игле (ПГА), USP 3/0–4/0, длина – 45 см, количество – 5 шт. (для кишечного шва);
- Полифиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал на атравматической колющей игле (лавсан), USP 2/0–0, длина – 45 см, количество – 5 шт. (для ушивания операционной раны), емкости для растворов (новокаин, хлоргексидин и др.).

Критерии оценки:

№	Критерий	Оценка	Описание
Общие критерии			
1	Постановка местной инфильтрационной анестезии	5 баллов	Местная инфильтрационная анестезия в ходе оперативного вмешательства выполнена правильно и обеспечила эффективное обезболивание животного;
		3 балла	Местная инфильтрационная анестезия в ходе оперативного вмешательства была недостаточной, повлекшей выраженное беспокойство животного;
		1 балл	Местная инфильтрационная анестезия в ходе оперативного вмешательства выполнена с небольшими нарушениями, вызвавшими возникновение осложнений (гематома мягких тканей брюшной стенки, брюшной полости, брыжейки);

		0 баллов	Местная инфильтрационная анестезия в ходе оперативного вмешательства выполнена с грубыми нарушениями техники;
2	Соблюдение принципов асептики и антисептики	3 балла	Соблюдены принципы асептики и антисептики;
		1 балл	Незначительные нарушения принципов асептики и антисептики (падение инструментов, касание нестерильной части операционного халата, маски и др.);
		0 баллов	Существенные нарушения принципов асептики и антисептики (попадание значительного количества кишечного содержимого в брюшную полость и др.);
3	Оценка срединной лапаротомии	3 балла	Кожа рассечена ровно по средней линии, апоневроз по белой линии;
		1 балл	Несоблюдение одного из параметров (кожа рассечена неровно, либо во время рассечения апоневроза произошло отклонение от белой линии и др.);
		0 баллов	Несоблюдение двух и более двух параметров;
4	Оценка резекционного этапа	5 баллов	Выполнена аккуратная мобилизация, а также резекция участка толстой кишки длиной ≥ 4 см;

		3 балла	Несоблюдение одного из условий (выполнена небрежная мобилизация либо резекция, в ходе которой произошло кровотечение или истечение кишечного содержимого, либо резецированный участок <4 см);
		0 баллов	Несоблюдение двух и более двух условий;
5	Оценка реконструктивного этапа	10 баллов	Технически правильно наложенный анастомоз, диаметр его не более чем на $\frac{1}{4}$ меньше диаметра толстой кишки, анастомоз проходим для ногтевой фаланги хирурга, снаружи швы практически не видны, окно в брыжейке ушито;
		7 баллов	Несоблюдение одного из условий наложения соустья;
		3 балла	Несоблюдение двух условий наложения соустья;
		0 баллов	Стеноз анастомоза (более 50% суживает просвет кишки, не пропускает фалангу), а также грубые нарушения техники наложения соустья;
6	Ушивание операционной раны	2 балла	Ушита послойно, швы наложены симметрично;
		0 баллов	Имеются любые недостатки в технике ушивания;
7	Правильность работы с инструментами, техника работы с тканями, соблюдение	3 балла	Соблюдение всех критериев;
		2 балла	Несоблюдение одного из критериев;
		1 балл	Несоблюдение двух критериев;

	правил асептики и антисептики	0 баллов	Грубые нарушения критериев работы бригады;
8	Регламент времени	7 баллов	Команда уложилась в регламент времени;
		– 1 балл	За каждые 10 минут сверх установленного времени;
Максимальное количество баллов			38 баллов

Ответственные за конкурс:

- Сулеймен Жусип, <https://vk.ru/zhusipsuleimen>;
- Барашкова Анастасия, <https://vk.ru/anastasiabarashkova>.



